

Cancer broncho-pulmonaire primitif et Tumeurs secondaires

Dr SEKHANE T

Service de pneumologie HMRU Constantine

Plan

I. Introduction

II. Intérêt de la question

III. Epidémiologie

IV. Facteurs de risque

V. Diagnostic positif

1. Circonstances de découverte

2. Examen clinique

3. Examens paracliniques

a. Imagerie

b. Biologie

c. Etape anatomopathologique

VI. Bilan pré thérapeutique

VII. Traitement

VIII. Pronostic

IX. Conclusion

I. Introduction

- Le terme de cancer désigne une prolifération anormale de cellules.
- Les poumons font partie de l'appareil respiratoire nécessaire à l'oxygénation du sang. Comme tous les tissus de notre organisme, le cancer peut atteindre les poumons et notamment les bronches.
- On parle de cancers bronchiques (ou broncho-pulmonaires) primitifs, en opposition avec les localisations pulmonaires d'un cancer d'une autre origine (métastases pulmonaires).

Introduction

- Le cancer broncho-pulmonaire représente un problème de santé publique dans le monde et en Algérie.
- En 2020 le cancer du poumon (CP) représentait le deuxième cancer en incidence dans le monde mais la première cause de décès par cancer
- Le tabagisme : facteur de risque principal, identifiable et évitable.
- Touche plus souvent les hommes que les femmes

II. Intérêt de la question

- Problème de santé publique mondial
- Morbidité et mortalité
- Cout très élevé
- Retentissement psychique
- Pronostic très mauvais
- Paradoxalement il reste évitable

III. Epidémiologie

1. L'âge :

L'âge médian de survenue est de 60 ans et 70 % des patients ont entre 50 et 70 ans.

2. Le sexe :

En France, le "sexe ratio H/F" est de 6/1 alors qu'il est de 2 à 3/1 aux Etats-Unis.

En Algérie le sexe ratio est de 7/1

III. Epidémiologie

1. Dans le monde :

- 2^{eme} cause de cancer ,
- Premier cause de décès par cancer

Épidémiologie

2. En Algérie :

- Le cancer bronchique est la 3^{ème} localisation chez la femme et la 2^{ème} localisation chez l'homme après le cancer colorectal.
- 4774 nouveaux cas avec 4333 décès ont été enregistré en 2020 (1^{ère} cause de décès par cancer)

IV. Facteurs de risque

1. Tabac :

a. Tabagisme actif:

- 80 à 90 % des CBP chez l'homme sont dus au tabac.
- De nombreux carcinogènes sont présents dans la fumée de cigarette.
- Les facteurs de risque les plus importants en termes de carcinogénèse sont l'âge de début du tabagisme (précocité) et sa durée et sa quantité

Facteurs de risque

b. Tabagisme passif

On estime que le tabagisme passif est responsable de 25% des CBP des non-fumeurs.

2. Les expositions professionnelles :

- Leur rôle est parfois sous-estimé (15% des CBP professionnels chez l'homme et 5% chez la femme.)
- L'asbeste, Le nickel, Le chrome, L'arsenic...etc

3. Les radiations

V. Diagnostic positif

1. Circonstances de découverte

a. **Signes respiratoires** : sont présents dans 60 % des cas.

- **L'hémoptysie**
- **La toux**
- Un épisode de suppuration bronchique et/ou Une pneumopathie aiguë.
- Une dyspnée est rarement révélatrice d'un cancer
- Une **douleur thoracique**, témoigne le plus souvent d'une atteinte de la plèvre.

Diagnostic positif

b. Signes liés à l'envahissement locorégional :

- **Une dyspnée:** paroxystique , parfois permanente ; une toux rebelle, sèche, quinteuse, un wheezing (GVA).
- **syndrome cave supérieur (VCS) :** envahissement de la VCS
- **Une compression nerveuse** peut être responsable de :
 - **une dysphonie:** en rapport avec la compression du nerf récurrent
 - **syndrome de Claude Bernard-Horner:** envahissement du gg stellaire (Pancoast tobias)
 - **un hoquet:** nerf phrenique
- **une dysphagie :** compression ou envahissement de l' oesophage

Diagnostic positif

c. Signes généraux :

- Les signes généraux sont très souvent présents mais trop souvent négligés.
- **L'amaigrissement**, souvent associée à une **anorexie** et **l'asthénie**.
- Le dégoût du tabac est parfois noté par les patients fumeurs.

Diagnostic positif

d. Syndromes paranéoplasiques :

- L'hippocratisme digital.
- L'hypercalcémie
- Le syndrome de Schwartz-Bartter : une sécrétion inappropriée d'ADH
- La pseudo myasthénie de Lambert-Eaton: fatigabilité musculaire extrême..
- La neuropathie sensitive de Denny-Brown

Diagnostic positif

e. Signes de dissémination métastatique :

- Il n'est pas rare que le cancer bronchique ne soit découvert qu'au stade de métastases
- Les deux disséminations métastatiques le plus souvent responsables de la découverte d'un CNPC sont les métastases **osseuses** et les métastases **cérébrales**.

Diagnostic positif

1. **Les métastases cérébrales:** peuvent être responsables, soit de crises d'épilepsie, soit d'un déficit moteur prenant l'aspect d'un accident vasculaire, soit d'un syndrome d'hypertension intracrânienne avec céphalées matinales, nausées, photophobie.
2. **Les métastases osseuses:** peuvent être révélées par des douleurs, une fracture pathologique, des manifestations pseudo-rhumatismales ou des signes généraux, neurologiques ou rénaux d'une hypercalcémie.

Diagnostic positif

3. Les métastases hépatiques: sont rarement révélatrices.

- Elles s'accompagnent le plus souvent d'une atteinte franche de l'état général.
- Elles se manifestent par des douleurs de la région hépatique, un ictère cholestatique, un hoquet ou une simple anomalie biologique.

4. Les métastases surrénales: peuvent être à l'origine de douleurs lombaires latéralisées quand elles sont très volumineuses.

Diagnostic positif

2. Examen clinique:

a. L'interrogatoire :Il recherche :

- Des signes thoraciques
- Des signes généraux

b. L'examen pulmonaire: recherche

- une immobilité d'un héli thorax,
- une douleur provoquée,
- une matité, une augmentation des VV ou diminution en cas d'épanchement associé, une diminution du MV.

Diagnostic positif

c. L'examen clinique extra-pulmonaire:

- Les aires ganglionnaires, en particulier le creux sus-claviculaire homolatéral.
- La taille et la consistance du foie et de la rate,
- La recherche d'un hippocratisme digital.
- La circulation veineuse est étudiée
- L'état neurologique est étudié par un examen clinique complet.
- Les localisations ostéo articulaires.

Diagnostic positif

d. Formes particulières :

- **Cancer de l'apex pulmonaire : Pancoast et Tobias**
 - Une lyse de l'arc postérieur des deux premières côtes, les vertèbres.
 - Douleur de l'épaule
 - Syndrome de Claude Bernard Horner
 - Troubles sensitivo-moteurs

Diagnostic positif

3. Examens paracliniques :

a. Imagerie :

- **Radiographie thoracique de face et de profil :**

- Permet de situer la tumeur et les éventuels troubles associés.

- **L'opacité hilaire** est l'image la plus typique.



Diagnostic positif

- **TDM Thoracique:** **Examen clé**, il permet de :
 - Préciser la taille et la localisation de la tumeur ainsi que ses rapports avec les structures voisines,
 - Rechercher des adénopathies médiastinales (intérêt de l'injection de PDCI)
 - Rechercher une autre localisation pulmonaire, hépatique ou surrénalienne.

Diagnostic positif

b. Biologie : Marqueurs tumoraux :

Il n'existe à l'heure actuelle aucun marqueur sérique spécifique du cancer bronchique.

c. Fibroscopie bronchique :

C'est l'examen clef du diagnostic car le plus souvent permet le prélèvement histologique qui déterminera le diagnostic de certitude.

Diagnostic positif

d. Ponction-biopsie trans-pariétale à l'aiguille

Elle est réalisée sous anesthésie locale sous guidage TDM.

Très utile pour les nodules et masses périphériques.

e. Médiastinoscopie :

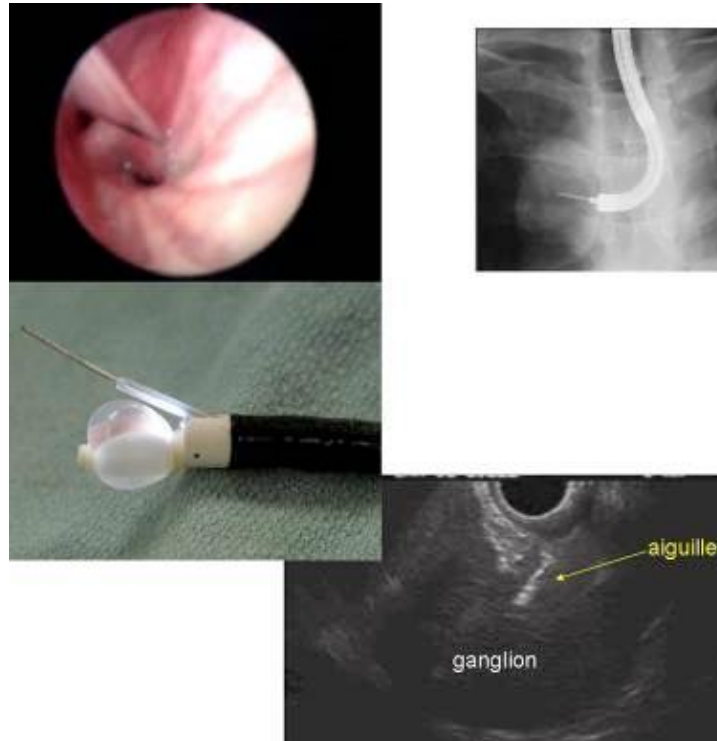
S'il existe un envahissement des ganglions médiastinaux.

f. Pleuroscopie :

Elle permet de biopsier les lésions périphériques et pleurales

Diagnostic positif

g. écho-endoscopie bronchique



VI. Diagnostic histologique

Les 2 grands types histologiques :

- **les cancers bronchiques « non à petites cellules » (CBNPC) : 80% des cas,**
eux-mêmes séparés en 3 sous-types histologiques :
 - Adénocarcinomes : 45% des cas (en augmentation)
 - Carcinomes épidermoïdes : 30-35% des cas
 - Carcinomes à grandes cellules : 5-10% des cas (sans
- Microscopie : différenciation malpighienne ou glandulaire nette
- **les cancers bronchiques « à petites cellules » (CBPC) : 15% des cas**

Diagnostic histologique

1. Adénocarcinome :

- Glandulaire
- En périphérie du poumon.
- Positifs pour un marquage par le Thyroid Transcription Factor-1 (TTF1) en immunohistochimie

Diagnostic histologique

- Carcinome à petites cellules:
- Tumeurs volumineuses, localisées aux voies aériennes proximales et au médiastin, entraînant une compression extrinsèque de l'arbre bronchique et des syndromes de compression médiastinale.
- Syndrome paranéoplasique fréquent.
- Positifs en immuno-histochimie pour un marquage par le CD56, *neurone specific enolase* (NSE), la chromogranine A, la synaptophysine

VI. Bilan pré thérapeutique

1. Bilan d'extension:

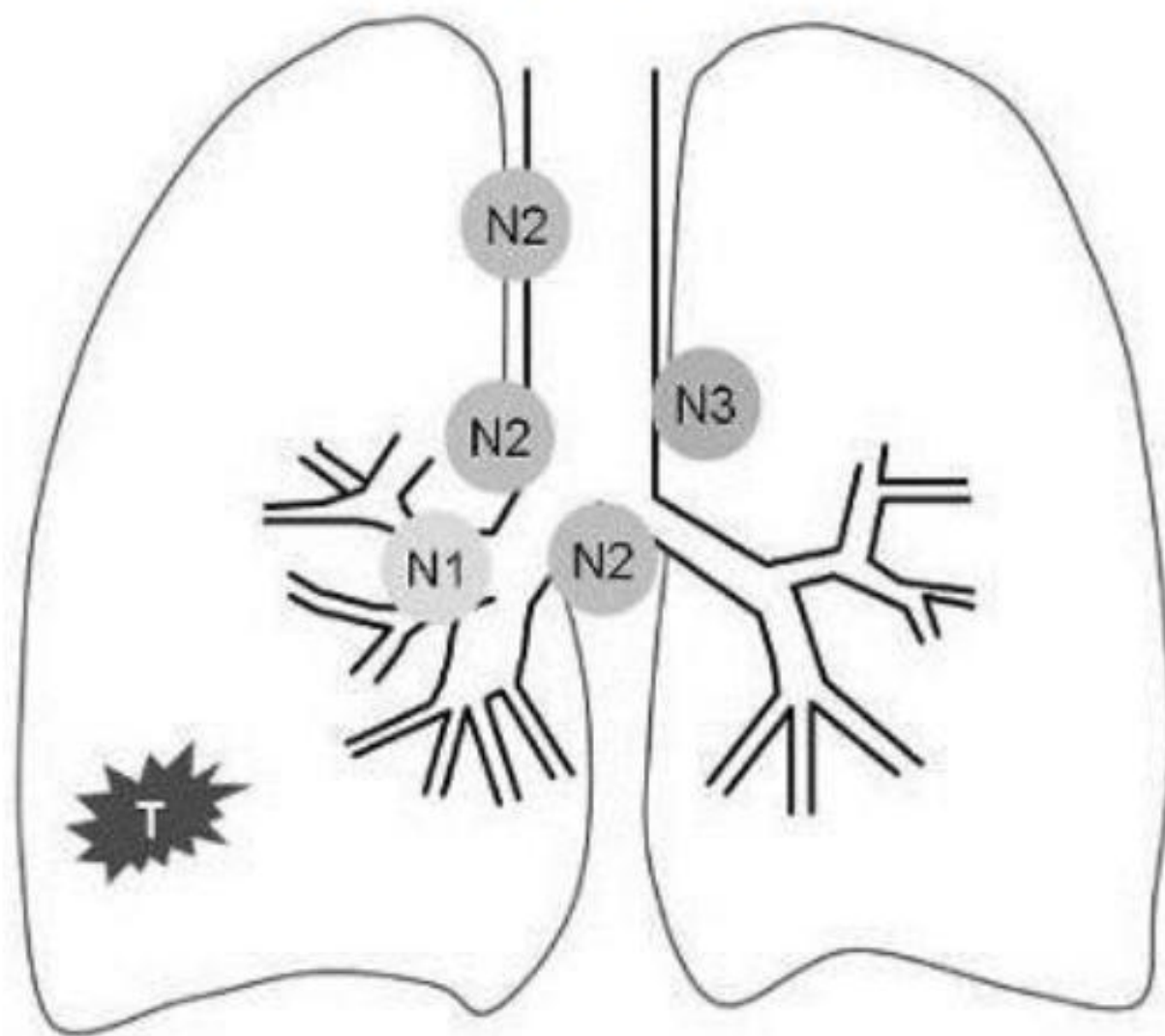
- Evaluer l'extension de la tumeur aux organes de voisinage, aux structures loco régionales ainsi que l'existence d'éventuelles métastases à distance.
 - Echographie / TDM Abdominale
 - TDM / IRM Cérébrale
 - Scintigraphie osseuse
 - PET-Scan

Bilan pré thérapeutique

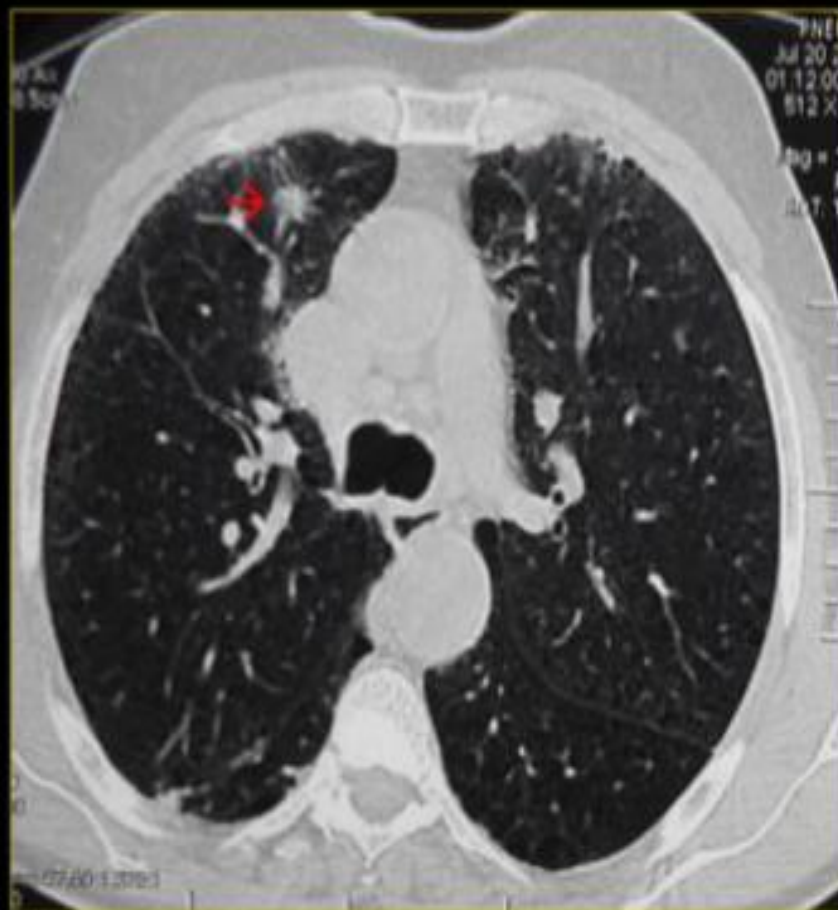
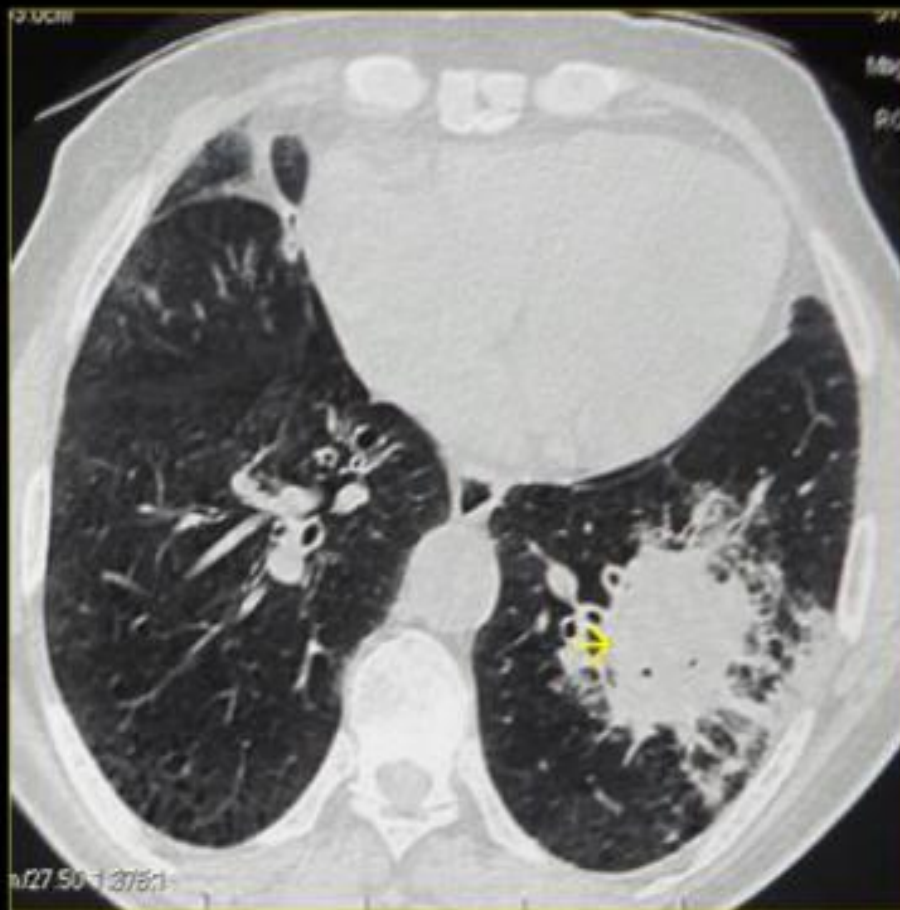
- Au terme de ce bilan, on peut établir la stadification TNM de la tumeur :
 - le **T** (tumeur) représente l'extension loco-régionale de la tumeur
 - le **N** (node = ganglion en anglais) représente l'extension ganglionnaire de la tumeur
 - le **M** (métastase) représente l'extension à distance de la tumeur

T - Tumeur	Tx	Tumeur primaire non connue ou tumeur prouvée par la présence de cellules malignes dans les sécrétions broncho-pulmonaires mais non visible aux examens radiologiques et endoscopiques.
	T0	Absence de tumeur identifiable.
	Tis	Carcinome <i>in situ</i> .
	T1	Tumeur de 3 cm ou moins dans ses plus grandes dimensions, entourée par du poumon ou de la plèvre viscérale, sans évidence d'invasion plus proximale que les bronches lobaires à la bronchoscopie (c'est-à-dire pas dans les bronches souches).
	T1a(mi)	Adénocarcinome minimalement-invasif
	T1a	≤ 1cm
	T1b	> 1 cm et ≤ 2 cm
	T1c	> 2 cm et ≤ 3 cm
	T2	Tumeur de plus de 3 cm, mais de 5 cm ou moins , avec quelconque des éléments suivants : -envahissement d'une bronche souche quelle que soit sa distance par rapport à la carène mais sans envahissement de la carène, -envahissement de la plèvre viscérale, -existence d'une atélectasie ou pneumonie obstructive s'étendant à la région hilare ((sub)lobaire ou pulmonaire)
	T2a	> 3 cm mais ≤ 4 cm
	T2b	> 4 cm mais ≤ 5 cm
	T3	Tumeur de plus de 5 cm et de 7 cm ou moins , ou associée à un(des) nodule(s) tumoral(aux) distinct(s) et dans le même lobe , ou ayant au moins l'un des caractères invasifs suivants : -atteinte de la paroi thoracique (incluant les tumeurs du sommet), -atteinte du nerf phrénique, -atteinte de la plèvre pariétale ou du péricarde.
	T4	Tumeur de plus de 7 cm ou associée à un(des) nodule(s) pulmonaire(s) distinct(s) comportant un envahissement quelconque parmi les suivants : -médiastin, -cœur ou gros vaisseaux, -trachée, -diaphragme, -nerf récurrent, -œsophage, -corps vertébraux, -carène, -nodules tumoraux séparés dans deux lobes différents du même poumon.

stadification de l'envahissement ganglionnaire



M1a Nodule Pulmonaire Controlatéral



Masse du segment latérobasal gauche de contours spiculés et irréguliers →
associée à un nodule spiculé du segment ventral du lobe supérieur droit →

Bilan pré thérapeutique

CLASSIFICATION PAR STADE

Carcinome occulte	Tx N0 M0	Stade IIIA	T1,2 N2, M0
Stade 0	Tis N0 M0		T3 N1 M0
Stade IA-1	T1a(mi) N0 M0		T4 N0,1 M0
	T1a N0 M0	Stade IIIB	T1,2 N3 M0
Stade IA-2	T1b N0 M0		T3,4 N2 M0
Stade IA-3	T1c N0 M0	Stade IIIC	T3,4 N 3 M0
Stade IB	T2a N0 M0	Stade IV-A	Tout M1a
Stade IIA	T2b N0 M0		Tout M1b
Stade IIB	T1,2 N1 M0	Stade IV-B	Tout M1c
	T3 N0 M0		

Bilan pré thérapeutique

2. Etat général:

- Il est évalué par plusieurs échelles dont:
- **l'indice de performance** (Performance Status de l'OMS ou ECOG) avec une échelle de 0 à 5.
- **L'index de Karnofsky** (échelle de 100-0) est également utilisé.

Bilan pré thérapeutique

Performance statut

- 0 personne normale – activité physique intacte – efforts possibles sans limitation
- 1 réduction des efforts – autonomie complète
- 2 autonome – se fatigue facilement – nécessité de se reposer (lit ou fauteuil) moins de la moitié des heures de veille.
- 3 personne dépendante – lever possible – nécessité de se reposer (lit ou fauteuil) plus de la moitié des heures de veille.
- 4 dépendance totale – état quasi grabataire – totalement confiné au lit ou au fauteuil

Bilan pré thérapeutique

3. Etat nutritionnel : L'état nutritionnel doit être systématiquement évalué.

4. Paramètres cardio-respiratoires:

- Les comorbidités cardiovasculaires sont systématiquement recherchées
- L'examen clinique recherche une BPCO, une insuffisance respiratoire et évalue la classe

fonctionnelle de la dyspnée.

- Les épreuves fonctionnelles respiratoires (au minimum une **spirométrie** et une mesure de la **DLCO**) sont réalisées dans tous les cas où un acte chirurgical paraît possible.

VII. Traitement

1. But:

- Augmenter l'espérance de vie
- Améliorer la qualité vie

2. Moyens:

- Chirurgie
- Chimiothérapie
- Radiothérapie
- Les soins de support

Traitement

3. Indications:

A. CBNPC

A.1. CBNPC résécables et opérables

- Ces cancers localisés (stades I et II) et certains stades IIIA représentent environ 20 % des cas.
- La résection de référence est la **lobectomie**
- Traitements complémentaires : une chimiothérapie adjuvante +/- une radiothérapie adjuvante.

Traitement

A.2. CBNPC non-résécables ou patients inopérables

- Ils représentent environ 35 % des cas
- Stades localement avancés non résécables (Stades IIIA, IIIB et IIIC)
- Association **radiothérapie + chimiothérapie (CT conventionnelle ; immunothérapie ou thérapie ciblée)** , concomitante ou séquentielle.

A.3. CBNPC métastatiques (stades IV)

- Représentent environ 45 % des cas.
- Ces patients relèvent d'un traitement par **chimiothérapie** exclusif

Traitement

B. CPC

- L'évolution sans traitement est rapide aboutissant rapidement au décès, en moins de 3 mois.
- La chimiothérapie est le traitement de référence du CBPC
- la tumeur est souvent très chimio sensible.
- 60% de réponse objective en 1ère ligne.

Traitement

- **Maladie étendue** (2/3 des cas) :

 **Chimiothérapie** (4 à 6 cures)

- **Maladie limitée** (1/3 des cas) :

 Association d'une **radiothérapie** idéalement de manière concomitante à la **chimiothérapie**; sinon, association séquentielle

Traitement

4. Traitement de support

Ces traitements doivent être entrepris dès l'apparition de symptômes, quel que soit le stade de la maladie.

- **La douleur:**
- par les antalgiques par paliers croissants en utilisant les antalgiques de classe I à III, sans hésiter à recourir aux dérivés morphiniques (classe III) + prévention de la constipation.

Traitement

- **Dyspnée :**
 - lymphangite carcinomateuse => CTC + Oxygénothérapie.
 - Pleurésie exsudative récidivante => Symphyse pleurale par talcage.
 - syndrome cave supérieur : anticoagulation, corticoïdes, discuter stent cave

VIII. Pronostic

Les principaux facteurs pronostic défavorables connus restent toujours :

- **Pour les patients opérés :**

- le stade croissant de la maladie

- le performance status élevé ;

Pronostic

- **pour les patients non opérés :**
 - le stade élevé,
 - le performance status élevé,
 - l'amaigrissement,
 - le taux de LDH élevé,
 - l'anémie et l'hyperleucocytose

Pronostic

Localisation Incidence France 2005	Données françaises (Étude PETRI sauf pour le cancer du pancréas)			Données américaines (SEER)		
	Stades	Survie relative à 5 ans (%)	Répartition des diagnostics (%)	Stades	Survie relative à 5 ans (%) 1999-2005	Répartition des diagnostics (%)
Poumon 31557	I	47	15,5	local	52,6	39
	II	32	13,6			
	III	22	20,0	régional	23,7	37
	IV	5	39,4	métastatique	3,5	19
	nd	nd	11,5	nd	8,5	5

IX. Conclusion

- Les cancers broncho-pulmonaires constituent un problème majeur de santé publique mondiale, avec une incidence en augmentation et une forte morbidimortalité
- étroitement liée au tabagisme, principal facteur de risque.
- Ils représentent l'une des premières causes de décès par cancer, malgré les progrès en matière de prévention, de diagnostic et de prise en charge.
- L'imagerie thoracique, en particulier la radiographie et surtout la tomodensitométrie (TDM), joue un rôle central dans le repérage des lésions, le bilan d'extension et la surveillance.
- Le diagnostic de certitude repose sur l'analyse anatomopathologique de prélèvements obtenus par fibroscopie bronchique, ponction transthoracique ou chirurgie, permettant de typer précisément la tumeur.

IX. Conclusion

- La prise en charge thérapeutique est multidisciplinaire : chirurgie pour les formes localisées résécables, radio-chimiothérapie pour les stades localement avancés, et traitements systémiques (chimiothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie) pour les stades métastatiques.
- Les soins de support et d'accompagnement (contrôle des symptômes, prise en charge nutritionnelle, psychologique et sociale, sevrage tabagique) sont indispensables à toutes les étapes de la maladie.
- Malgré ces stratégies, le pronostic reste globalement défavorable, en particulier aux stades avancés, soulignant l'importance de la prévention du tabagisme et du diagnostic précoce.

Tumeurs pulmonaires secondaires

I. Introduction

- Le poumon est un site métastatique privilégié pour de nombreux cancers.
- Elle représente 20 à 30% de toutes les autres métastases.
- Tous les cancers peuvent se compliquer de métastases pulmonaires,
- le plus souvent dans les deux premières années d'évolution, le temps de latence pouvant atteindre une vingtaine d'années.

II. Intérêt de la question :

- Fréquence: 2 ème localisation métastatique après le foie.
- Le diagnostic est facile si la néoplasie primitive est connue et il est difficile dans le cas contraire car il faut reconnaître le caractère métastatique de la lésion puis d'en préciser l'origine.
- Problème thérapeutique.

III. Physiopathologie

- il existe deux modes de dissémination possibles:
 1. **Dissémination Hématogène** : principal mode de dissémination métastatique au poumon.
 - Ce mode se traduit par le développement en plein parenchyme, de nodules tumoraux uniques ou multiples.
 - Le poumon peut être le premier organe touché

Physiopathologie

2. Dissémination lymphatique : Ce mode de dissémination est responsable des aspects de :

- **lymphangite tumorale**
- **Adénopathies médiastinales.**

IV. Clinique

- Asymptomatiques souvent (85%)
- Polymorphes
- Signes fonctionnels respiratoires:
 - Toux
 - Douleur
 - Dyspnée
- Signes physiques:
 - Pauvres
- Signes généraux:
 - Ceux de la maladie cancéreuse

V. Examens complémentaires

- La découverte radiographique d'opacités rondes multiples au cours de la surveillance radiographique d'un cancer connu est le cas le plus fréquent.

Examens complémentaires

Examen de référence : **tomodensitométrie thoracique (TDM)**

- L'aspect radiographique est important à reconnaître, des images nodulaires à contours nets, le plus souvent distales ; uniques ou multiples
- En règle, les nodules sont bien limités, de tailles différentes (quelques millimètres à plusieurs centimètres), arrondis et réguliers, plein, non calcifiés, de localisation bilatérale souvent

Examen complémentaires

- Fibroscopie bronchique : avec aspiration ; brossage ; lavage ; biopsie. La rentabilité de l'examen est habituellement faible du fait du caractère périphérique des lésions.
- Ponction sous repérage TDM: bonne rentabilité.
- Biopsie chirurgicale: sous vidéo-thoracoscopie.

Résultats : anatomo-pathologie ± immuno-histochimie

VI. Formes cliniques

1. La forme nodulaire:

a/ unique : 2 à 10 % des nodules pulmonaires sont des Métastases

- Aspect RX et TDM non spécifique
- PET scan +++ (scintigraphie à émission de positon)
- **Pole primitif : rectocolique, sarcome, rein, sein, testicule, mélanome**

VIII. Formes cliniques

b/ multiples « en lâcher de ballon »

- Pole primitif souvent connu, taille variable, nombre > 03
- Siège périphérique , bases et sous pleuraux
- pneumothorax = sarcome ou tumeur testiculaire
- **Pole primitif : estomac, pancréas, sein, prostate.**

Aspect radiographique « lâcher de ballon »

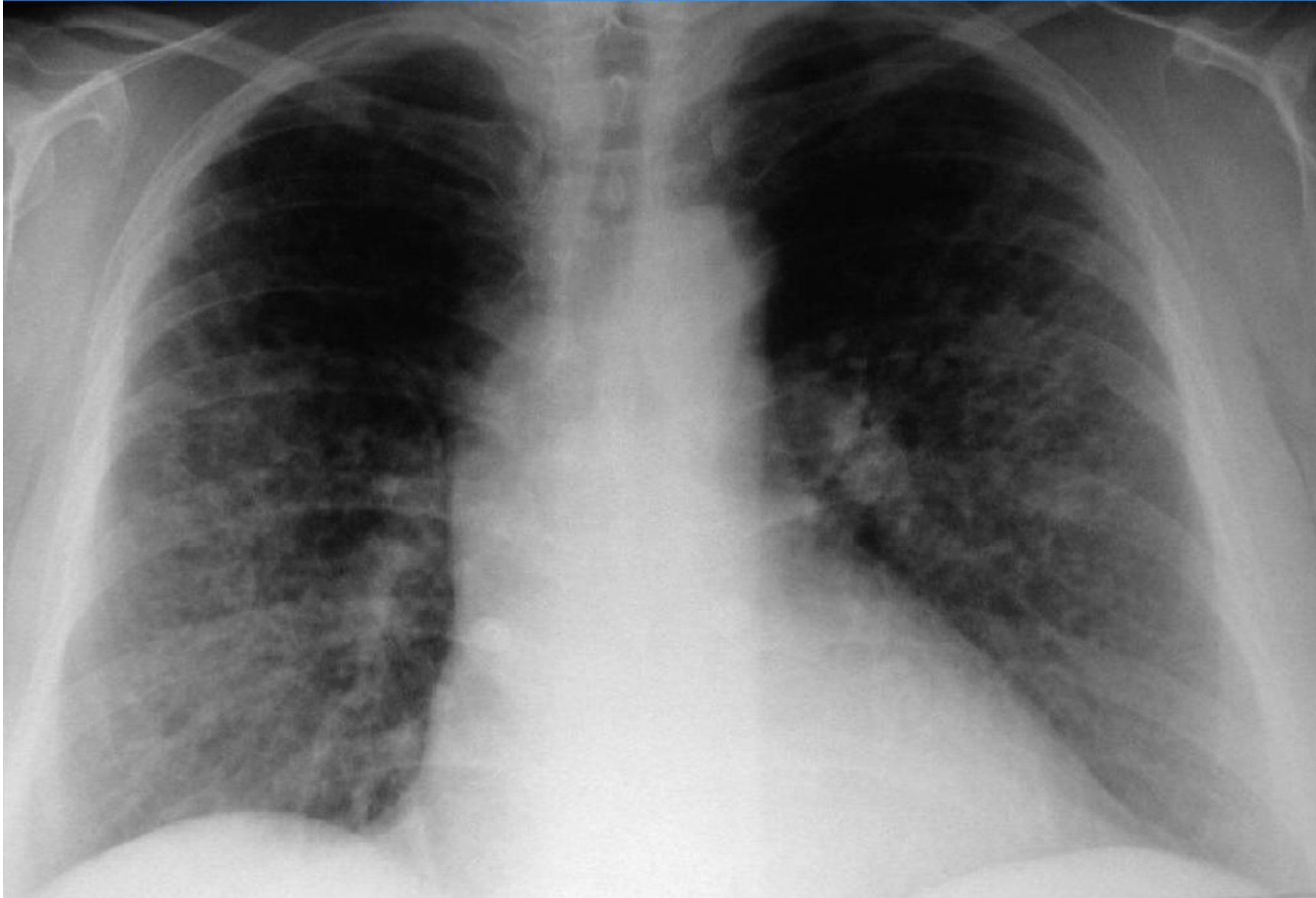


Formes cliniques

2. La lymphangite carcinomateuse:

- Dissémination lymphatique.
- typiquement: opacités réticulo nodulaires, péri lymphatique et péri broncho vasculaire bilatéral, avec des lignes de Kerley de type A et B associé à un épanchement pleural.
- Parfois focale
- Clinique dyspnée d'aggravation progressive
- Dgc différentiel avec l'IVG
- **Pole primitif : sein, estomac, pancréas, prostate, col de l'utérus.**

Image de lymphangite carcinomateuse

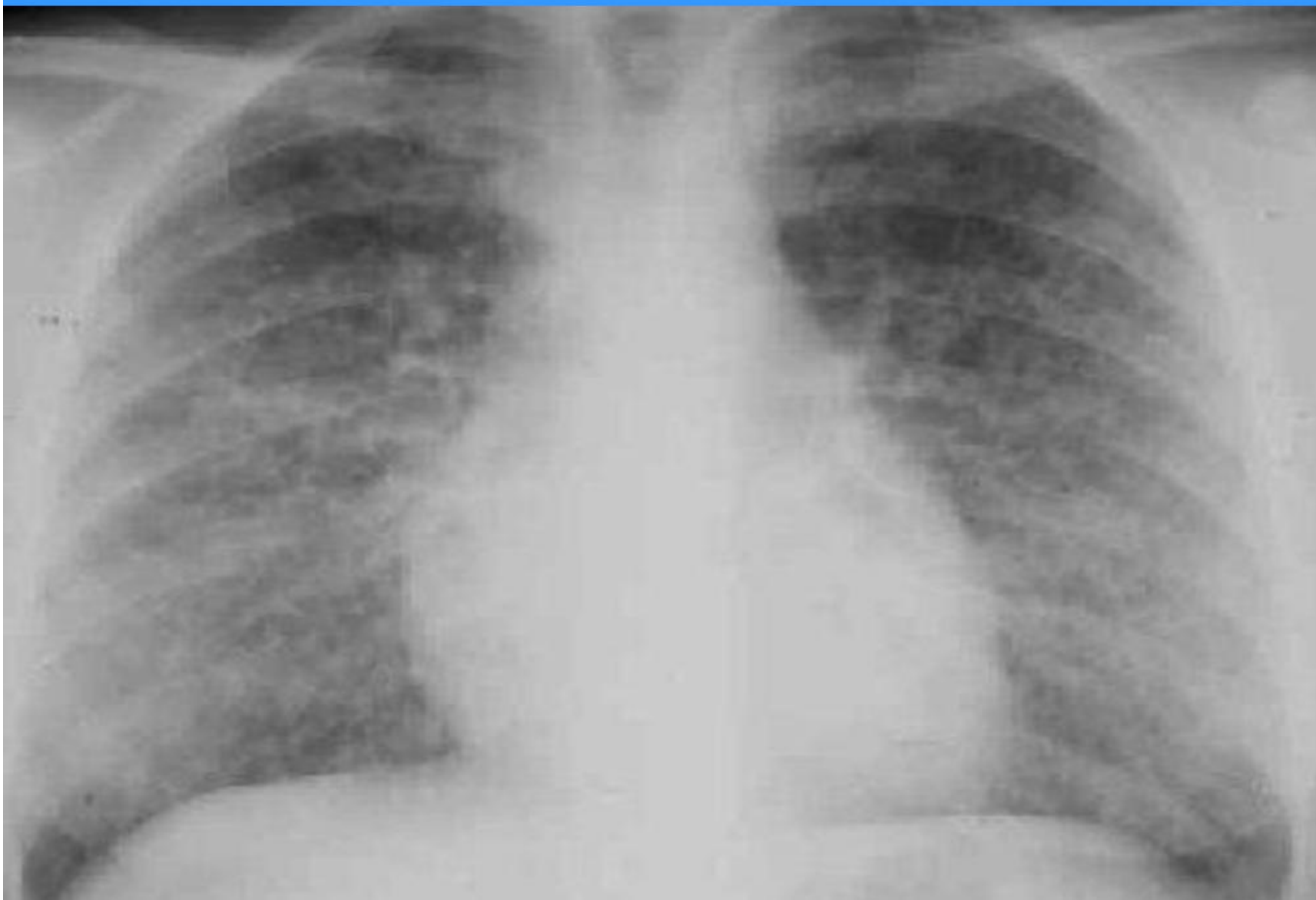


Formes cliniques

3. La carcinose miliaire:

- Dissémination hémotogène.
- typiquement: Aspect de granule bilatérale micro et macronodulaire que miliaire vraie,
- Parfois associée à des images réticulaires épaisses des bases
- Clinique: Dyspnée : Weezing et hémoptysie
- **Pole primitif : sein, prostate, thyroïde.**

Aspect radiologique « carcinose miliaire »



Formes cliniques

4. Les métastases endo bronchique, pleurale et ganglionnaire:

a - Métastase endobronchique:

- Rares, Dgc différentiel avec les tumeurs primitives.
- Pole primitif : **colon , rein ,sein et mélanome.**

Formes cliniques

b - Les métastases pleurales et ganglionnaire:

- Adénocarcinome pulmonaire
- mammaire
- Ovarien
- Gastrique et colique
- Lymphomes ou thymomes malins.

Formes cliniques

5. L'embolie tumorale:

- **L'embolie vasculaire:** associe un matériel néoplasique et cruorique
- Se voit au cours du cancer de l'estomac, sein, rénal et du foie
- Donnant des obstructions vasculaires pulmonaires sans envahissement des alvéoles ou de l'Interstitium.
- **Clinique :** cyanose, douleur et hémoptysie.
- **Diagnostic :** angiographie pulmonaire.

IX. Traitement

1. La chirurgie des métastases:

- **Curative:** pour les métastases uniques.
- **Palliative:** réduction tumorale pour les méta multiples avec ou sans chimiothérapie néo- adjuvante.

2. Radiothérapie:

- Métastase bronchique isolée
- Indiquée dans les séminomes et sarcomes et antalgique

Traitement

3. La chimiothérapie:

- Efficacité: testicule, ovaire, rein , et prostate
- Protocole associant plusieurs drogues

4. L'hormonothérapie :

Sein , rein, et prostate: a base se progestatifs et oestrogènes

5. Soins palliatifs:

traitement de la douleur, dyspnée, troubles psychiques

X. Conclusion

- Les localisations pulmonaires secondaires représentent l'un des sites métastatiques les plus fréquents au cours de l'évolution des cancers, la majorité des tumeurs solides pouvant donner des métastases pulmonaires.
- Elles sont évoquées devant un contexte clinique de cancer connu associé à des images radiologiques évocatrices, ou bien découvertes de façon fortuite lors d'un bilan d'imagerie réalisé pour une autre indication, puis confirmées par l'analyse histologique de prélèvements tissulaires.
- Leur prise en charge thérapeutique est déterminée avant tout par les caractéristiques du cancer primitif (type histologique, extension, sensibilité aux traitements) et s'intègre dans une stratégie globale décidée en réunion de concertation pluridisciplinaire.